

Meeting Transcription

Meeting started: May 22, 2026, 1:04:35 PM

Meeting duration: 42 minutes

Meeting participants: GUSTAVO VICENTE IGLESIAS, Karina Cardone

[View original transcript at Tactiq.](#)

Transcript

00:00 Karina C.: Bueno, a ver la pongo. A ver ahora si está tomando Sí ya lo está tomando.

00:05 GUSTAVO V.I.: Sí bueno fantástico

00:08 Karina C.: Bueno entonces te decía el buscador por barrio perfecto después en la página

00:13 GUSTAVO V.I.: En la página de pantalla de persona.

00:16 Karina C.: de persona para que busque el barrio después el otro punto que me anoté que ya lo vimos, es reforzar la dirección con el número eso que vos me dijiste que ibas a hacer y bueno obviamente lo de GPS que igual le vamos a decir que abran la encuesta en la casa, no que se la lleven a un centro de salud después.

00:35 GUSTAVO V.I.: Y con la y a ver y por qué te remarco esto? Porque tiene que ser con la aplicación nativa con la que está en la tablet.

00:43 Karina C.: Sí, sí, sí sí, sí, por eso el martes antes que vos llegues va a haber un refuerzo de todo, o sea, tiene tiene que ver también con otras cuestiones de carga, pero eso ya lo anotamos que sea que vayan a la casa que que empieza una

00:53 Karina C.: Hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Tactiq AI. <https://tactiq.io/r/transcribing>

00:59 Karina C.: encuesta y eventualmente. y después le queda algo por cargar Bueno lo pueden cargar después pero

01:04 GUSTAVO V.I.: Sí, eso sí, Lo importante es la vivienda porque es la única vez que vamos.

01:09 Karina C.: Sí, sí, sí, sí, quédate tranquilo, que eso se va a reforzar Pero bueno, estoy haciendo un repaso de las cositas que que hablamos que con vos y con las chicas después. Me habías dicho que coincidía la fecha las fechas de domicilio y la fecha de consultorio te acordás que vos veías bueno, Aldana me dice que carga y eso lo vi la fecha a domicilio distinta a la fecha de consultorio, pero la visualización la vista digamos está tirando siempre la fecha de carga.

01:44 Karina C.: Entonces por eso es que te repite la fecha como el dan está cargando todo el mismo día de esos viejos. Ella está poniendo fechas diferentes, pero lo que me dice si querés Hagamos una prueba en pacientes en personas.

02:00 GUSTAVO V.I.: en persona No, no, Si está así lo reviso, si ya ya lo probaron.

02:05 Karina C.: Sí que en la fecha de cuando buscas, por ejemplo entras a un paciente.

02:11 GUSTAVO V.I.: Entramos. Y vamos al control.

02:14 Karina C.: La fe al control ahí en la vista ves? Que aparece, por ejemplo 22 de mayo 22 de mayo, pero que el interior el ella está eso.

02:21 GUSTAVO V.I.: Ah está bien No porque yo guardo siempre la fecha de modificación y lo que tiene acá es la fecha de modificación Pero la fecha de carga, es esta.

02:33 Karina C.: claro Sí, Y ella dice está poniendo fechas distintas Entonces es solo un poco.

02:40 GUSTAVO V.I.: a ver ahora cómo me sale acá para No ves que acá me sale bien No acá, me sale bien Mira dieciocho del cinco que fue la fecha de carga Sí y está el 22.

02:49 Karina C.: En bien perfecto. perfecto

02:53 GUSTAVO V.I.: Entre los dos esta mide el primero y el segundo.

02:57 Karina C.: Bien, bueno, entonces Está bien yo porque me quedé con eso que habíamos hablado.

03:02 GUSTAVO V.I.: Esta es la fecha de última modificación, digamos.

03:04 Karina C.: Okay y

03:08 GUSTAVO V.I.: También acá lo puedo poner también la otra fecha la que está adentro

03:11 Karina C.: Sí dice que la fecha de carga estaría mejor no la fecha de modificación porque va a pasar eso viste Hay alguno Que por ahí es viejo y está mejor que se vea la fecha real de de en que digamos se hizo la consulta o el

control o lo que sea.

03:30 GUSTAVO V.I.: ok

03:32 Karina C.: Perfecto, después vamos a los filtros los primeros filtros.

03:41 GUSTAVO V.I.: de personas

03:43 Karina C.: Empecemos por persona después por vivienda también.

03:49 GUSTAVO V.I.: Ahí estamos.

03:50 Karina C.: Ah okay, tenemos filtro de El personas los que están solo en el programa que está tomando.

04:04 GUSTAVO V.I.: Ahora ya no te podría decir de tener que revisar en su momento, pero es lo que están en el programa son los que chequeaste en la casa que entraron al programa en el domiciliario.

04:14 Karina C.: Que se hicieron algo que se hicieron un laboratorio o toma de tea?

04:16 GUSTAVO V.I.: sí No, los que viste que aceptan el tratamiento.

04:23 Karina C.: Sí pero eso pasa en el consultorio porque ahí Ahí voy si es eso, pues Y fíjate que vos marcas o desmarcas, mira desmarcás programa.

04:32 GUSTAVO V.I.: Te marco.

04:33 Karina C.: Sí y el número es el mismo entonces lo que queremos que sucede ves que dice 772 pacientes. Y si lo marcas igual son 772 pacientes en cambio.

04:45 GUSTAVO V.I.: sí

04:47 Karina C.: El programa es que haya entrado el programa te explico para que se entienda vos y vos puedas a partir de eso hacer la diferencia los que están en programa esta Va a ser la gran diferenciación es el tipo que entra a la casa que te dice Okay y se toma al menos la presión o al menos el laboratorio es el que te dijo que dale. el que queremos Que aparezca como Solo tea o si se quiere programa polilet por ahí, le tenemos que cambiar el nombre, es el que está en tratamiento polillep efectivamente Y ese es el que recibió medicación.

05:31 GUSTAVO V.I.: Pero habría que poner un filtro nuevo.

05:33 Karina C.: Sí porque fíjate que ese lo marcazo de marcas y no cambia y yo lo que

05:37 GUSTAVO V.I.: No, pero no debe ser porque está en todas las personas que están acá lo tienen, eh?

05:42 Karina C.: no, porque solamente

05:44 GUSTAVO V.I.: Me voy a fijar. Porque está acá es no, dónde está?

05:47 Karina C.: Porque que porque fijate que dónde estás, se están en consultorio.

05:52 GUSTAVO V.I.: Entrando en domicilio Acá no está marcado.

05:56 Karina C.: Claro pero ese el domicilio el accede al programa, por eso vamos a diferenciar porque quizás tenga que ser dos filtros distintos o por ahí.

06:03 GUSTAVO V.I.: Por eso te digo el filtro que estamos viendo ahí el que filtro que estamos viendo recién es este.

06:09 Karina C.: sí, okay, Bueno que excede al programa

06:11 GUSTAVO V.I.: Ahora si vos querés que accedió el programa que está como sacamos la medición en el dashboard, ese sería lo que me dijiste recién que sería el que fue al consultorio y está medicado este.

06:25 Karina C.: Está medicado ese sería como en tratamiento polillep, así que por ahí se podría poner un filtro si se puede sí Exacto en tratamiento polillep

06:34 GUSTAVO V.I.: Sería este este número te tiene que dar el 125 este.

06:39 Karina C.: exactamente el resto está bien porque el resto es efectivamente el que dijo que sí, aunque sea que le tomes la presión aunque sea que le hagas un laboratorio porque de alguna manera Está aceptando que le tomes un laboratorio o algo, pero no entra al circuito de poli. Lep se entiende entonces por ahí por diferenciar programa. Que en realidad programas van a estar todos los registrados porque nosotros no registramos el que dice que no el rechazo no lo registramos el que te dijo no Entonces ese lo sacamos por otro lado.

07:16 Karina C.: Que si eso es otra pregunta, que te quiero hacer, pero para el para el dashboard, pero no te quiero manera, me lo voy a notar. Ahora te voy a decir por qué? Visualizando Esto entonces podemos poner programa todo el que accede a esto al de la visita que vos dijiste lo saco de acá es todo tipo que dijo Okay Tómame la presión Okay acepto un laboratorio, o sea, por una u otra cosa te está aceptando, pero en tratamiento polilep habría que ponerlo adelante Estaría bueno tener un filtro que lo vamos a llamar eso en tratamiento polilleta.

07:55 Karina C.: Y ese es el que efectivamente entra a que tiene hta y entró al al programa y eso lo tenés en consultorio, lo sacas de consultorio, viste que ahí está la

08:04 GUSTAVO V.I.: Sí, sí.

08:07 Karina C.: marquita. Te acordás que ahí se entrega de medicación perfecto.

08:13 GUSTAVO V.I.: De hecho son estos 125 famosos que vos tenés ahí.

08:13 Karina C.: Bien.

08:19 GUSTAVO V.I.: una una discordancia pero son acá nos marca 125

08:20 Karina C.: Sí, Exacto Exacto bien. Sí otra cosa lo otro está acepta laboratorio perfecto. Estoy viendo, no acepta, pero en tratamiento ese hay que sacarlo bus él no acepta, pero en tratamiento no sé por qué está, no entiendo muy bien, no acepto, pero un tratamiento eso habría que sacarlo.

08:45 GUSTAVO V.I.: El tratamiento con su médico debe estar viste que en antecedentes.

08:49 Karina C.: ah, no, pero es esa quemos lo De ahí de filtro, eh, Te digo, no del dashboard, después lo vemos.

08:55 GUSTAVO V.I.: Sí sí, está bien Igual de todo. Esto está quedando grabado y después me

08:57 Karina C.: perfecto

08:58 GUSTAVO V.I.: mandaras la tarjeta de la tarea por transcripción pero

08:59 Karina C.: Okay pero yo para que por ahí se vea entonces hay que sacar no acepta pero en tratamiento Chau que no esté y con antecedentes tiene que tomar solo los antecedentes de hipertensión, no de cualquier antecedente porque vos podés

09:17 GUSTAVO V.I.: Ah bueno

09:17 Karina C.: tener antecedente renal de una patología renal o un antecedente de dislipemia.

09:22 GUSTAVO V.I.: A ver si lo marcamos este que tiene 36 o me va a quedar.

09:25 Karina C.: sí

09:31 GUSTAVO V.I.: Así me queda en ht, así me quedan todos y a ver.

09:34 Karina C.: Y solo queremos en esta instancia para la visualización rápida con antecedentes de hta.

09:41 GUSTAVO V.I.: bueno, pero le ponemos el cartelito antecedente de

09:44 Karina C.: Sí y solo que tenga antecedentes de hta. Sí, perfecto.

09:56 GUSTAVO V.I.: Igual estos filtros te pregunto, te pregunto por esto porque yo ahora no tengo

09:56 Karina C.: antecedentes de HP

10:02 GUSTAVO V.I.: tiempo de cambiarlo de acá calmarte.

10:05 Karina C.: sí

10:06 GUSTAVO V.I.: Estos filtros igual interesarían que los tenga quien hace la administración de esto.

10:12 Karina C.: Sí, no, la gente no.

10:14 GUSTAVO V.I.: la gente no

10:14 Karina C.: No, el agente lo único que tiene que hacer es tener la condición de carga, nada más todas estas visualizaciones, las ve Mariana las veo yo las veo Aldana como que las que estamos como detrás haciendo el seguimiento. Sí, Y otra cosa que se me ocurre es el filtro con antecedentes de hta, que este lo vas a sacar también y vamos a agregarle con tea alta viste como lo mismo que responde un poco.

10:46 Karina C.: A al dashboard viste que yo te dije y ahora lo igual lo refrescamos que tenga

10:54 GUSTAVO V.I.: El de las cien personas que tuviera antecedentes.

10:56 Karina C.: sí Exacto Entonces que haya dos botoncitos uno que te diga tú tiene antecedente ht, o sea, es un paciente diagnosticado, pero tiene hta y el otro botón que te diga, te ha alterado que encuentre esos que tienen de alta.

11:12 GUSTAVO V.I.: Que son los que encontraste, digamos.

11:15 Karina C.: Sí que son los que encontraste en verdad. Es

11:16 GUSTAVO V.I.: El que la persona no sabía.

11:19 Karina C.: Es que la persona no sabía o sea, porque por un lado vos vas a la casa y el tipo por ahí en ese momento tiene la presión normal, pero es un paseo hipertenso la tiene normal porque está medicado porque si es un tratamiento de la listo es igual nos sirve lo que lo queremos ver porque le vamos a ofrecer, cheque, querés cambiar tu tratamiento, quieres seguir etcétera, pero después está el otro captado ese que no tiene ni idea de la vida. Vos le tomaste la presión. Él te va a decir tenés hipertensión antecedentes, no para nada Y vos lo vas a tomar la presión y resulta que el tipo está con 170 980 130, no sé.

11:57 Karina C.: Ese es un tipo que está captado, sí que no, ni lo sabía Está captado Pero los dos, son van a ser hipertensos.

12:03 GUSTAVO V.I.: Sí sí también te entiendo.

12:04 Karina C.: Perfecto bien, entonces para los filtros, eso de ahí, adelante y para vivienda. Si podemos ahora seguir a vivienda, tenemos contrata, hay uno

que dice con tratamiento ese que sacarlo no sirve en esta instancia de vivienda. Así que si hay que sacarlo y cuál otro Son acumulador, déjame ver.

12:33 GUSTAVO V.I.: Ahora sí le sumo el barrio.

12:35 Karina C.: Ah perfecto Bueno entonces acá habría que sacar solo el que diga el que dice con tratamiento ese hay que sacarlo. Y después solo accedidas, perfecto, o sea, eso va a variar porque te va a descartar las rechazadas y ausentes. A ver si ahora lo borrás le pones ahí. No está tomando ahí me parece, mira.

13:06 GUSTAVO V.I.: Nada, porque tengo que aplicar el filtro Perdón acá, lo puse tenés que aplicar el filtro.

13:11 Karina C.: Y por ejemplo, ahí te da 600 y pico.

13:12 GUSTAVO V.I.: Ahí está. shift 649

13:20 Karina C.: Sí, a ver si solo accedidos lo toma.

13:23 GUSTAVO V.I.: Pero no cambia las viviendas son viviendas cargadas.

13:25 Karina C.: No está cambiando. Sí pero sabes que ahí Tendría que haber como por eso eso si querés después

13:32 GUSTAVO V.I.: el cartel de acá Este que igual que el de personas suma el total de persona

13:32 Karina C.: no sé si lo puedes ver.

13:37 GUSTAVO V.I.: activa

13:40 Karina C.: Bueno, porque ese tiene que pegar viste que en una vivienda o está rechazado o está? Qué es lo que figura en el dashboard? O está la

13:47 GUSTAVO V.I.: pero este este total para este total lo llevamos como control medio de chile, hay tantas y cargué para saber cómo hacemos en Una memoria si querés puedo poner más.

14:02 Karina C.: Para mí pueden estar todas porque entonces ahí me va a aparecer el total total tanto de la rechazada como El ausente y cuando yo pongo solo accedidas ese filtro me remite a la que me dejó entrar y yo puse pude hacer una acción se

14:18 GUSTAVO V.I.: Está bien este ahora es toda si querés puedo poner un paro más abajo diciendo

14:18 Karina C.: entiende.

14:21 GUSTAVO V.I.: que Cuál es la cantidad de cada cosa.

14:25 Karina C.: Sí o o en el filtro claro, el mismo filtro que si está tildado solo te

marqué

14:25 GUSTAVO V.I.: Aunque respete el filtro

14:30 Karina C.: las accedidas Y si está destilado te marca las que rechazaron todas todas todas todas todas todas todas todas.

14:36 GUSTAVO V.I.: Sí por eso te digo este este no responde a filtros solo saca totales.

14:41 Karina C.: Ah okay, Bueno si podemos poner el filtro me gustaría Okay genial.

14:46 GUSTAVO V.I.: Sí sí o dejar este número porque viste este número lo usan mucho para saber los que cargan si les cargó o no lo podemos bajar por acá como totales y acá sí, acá te hago un número de que actúe el filtro.

15:05 Karina C.: Sí igual se tendría que repetir en alguna instancia.

15:08 GUSTAVO V.I.: En alguna instancia, sí. Cuando están cuando están todos, si estuviera así ahí tendría que

15:11 Karina C.: Bueno fíjate cómo queda mejor.

15:15 GUSTAVO V.I.: repetirse, pero si está así ya no se repite.

15:17 Karina C.: Sí claro, yo creo que tiene que estar digo para no tener dos en digamos tiene que estar sin el cosito azul. Y cuando se quiere ver accedidas marcar el cosito azul.

15:31 GUSTAVO V.I.: Bueno este de entrada que sea así y listo

15:33 Karina C.: Sí, genial.

15:39 GUSTAVO V.I.: O sea que para que así nos agarra la que nos está grabando el texto entonces en la página de vivienda el Solo accedidas queda en off. Y cuando alguien quiere empieza a actuar sobre los filtros Y eso mueve la

15:54 Karina C.: sí

15:55 GUSTAVO V.I.: cantidad de vivir la cantidad de viviendas listo.

16:00 Karina C.: Bien, perfecto. Listo Esto está Gus eran los filtros y quiero ir un momentito al dashboard y yo ya terminó con mi parte. Que me pasa, ves que acá refleja lo que estamos hablando ahora efectivamente las que se es un poco lo que nos va a dar el filtro.

16:24 GUSTAVO V.I.: Sí, sí.

16:25 Karina C.: Perfecto, lo de presión arterial ya había quedado, no? Que era conté

16:30 GUSTAVO V.I.: Este era el consultorio este.

16:31 Karina C.: alterada. No, pero principio viste, yo te había dicho ahí decía Entonces eso sí, O sea

16:36 GUSTAVO V.I.: Ah sí este también.

16:40 Karina C.: si ya el paciente tiene hipertensión que te dice que tiene hipertensión ya no lo cuento para para t, alta. En el domicilio. Se entiende. No, el que dice presión arterial me lo agrandas un chiquitín, puede ser?

16:58 GUSTAVO V.I.: Ahí.

17:04 Karina C.: sí, ves del total de personas evaluadas, ya sea con hipertensión o te alta vos acá figura 751 No Entonces vamos a suponer vamos al 100 otra vez para que se entienda yo y en el domicilio en el domicilio este el módulo 2 es domiciliario Ah por ahí hay que

17:22 GUSTAVO V.I.: sí

17:27 Karina C.: poner presión arterial y entre paréntesis domicilio. Vamos a con el 100 que es más para mí es más práctico. Yo agarré y enteré en el domicilio a 100 personas.

17:43 GUSTAVO V.I.: ok

17:43 Karina C.: De 100 personas resulta que 50 me dijeron que tienen hipertensión, ya lo saben.

17:44 GUSTAVO V.I.: sí

17:52 Karina C.: Con lo cual, esa gente ya tiene hipertensión y después 20. No lo sabían y resulta que tiene la tea alta, entonces ahí me va a quedar yo al que tiene ya detecté con hta, no lo vuelvo a sumar con t alta, porque ya está entonces acá me va a quedar que el 70% porque son 50 más 20 tiene

18:13 GUSTAVO V.I.: no

18:21 Karina C.: hipertensión o presión arterial alta. Vamos a poner presión arterial alta. Y ahí hago la diferenciación que 50 ya tenían antecedentes y 20 fueron captados.

18:38 GUSTAVO V.I.: Bien.

18:39 Karina C.: Se entendió ahí perfecto Yo ahí no sé si lo refleja completamente y me

18:40 GUSTAVO V.I.: sí

18:44 Karina C.: perdí un poco, la verdad.

18:45 GUSTAVO V.I.: Sí acá, estoy refleja eso.

18:46 Karina C.: Okay si lo refleja listo por ahí lo que entonces agregaría es

presión arterial y entre paréntesis domicilio porque esa es la parte que sucede en el domicilio.

18:58 GUSTAVO V.I.: ok

19:01 Karina C.: Viste que acá dice del total evaluado?

19:08 GUSTAVO V.I.: Cómo Sí, de hta alta sí son 571.

19:18 Karina C.: exacto Pero entonces esa parte es para mostrarlas se entiende porque a mí me interesa que haya una desagregación primero que el 70% tiene o por atención o porque se captó presión alta. Y después la desagregación en esto que dije antes 50 eran con hta de antecedente y 20 fueron captados, que ahí sí lo pusiste.

19:45 GUSTAVO V.I.: Sí, Acá está en el 46 y el 31.

19:47 Karina C.: claro, Exacto eso Quizás lo refleja y yo no lo terminé de no me daban las sumas Hay algo que me pasó a mí que no me da por ahí miré uno viejo o por ahí miré una captura de pantalla o algo y

20:01 GUSTAVO V.I.: Porque vos miraste ese me pasaste este primero que también me pasaste este.

20:06 Karina C.: Entonces por ahí me yo me confundí, pero si está y refleja eso.

20:09 GUSTAVO V.I.: Después después me pasaste el módulo tres que era en consultorio.

20:13 Karina C.: Bueno, el módulo tres Es que esto sí creo que está perfecto, cuántos van

20:14 GUSTAVO V.I.: Que era el del total de esto. fueron a

20:19 Karina C.: perfecto y de esos ahí Sí cuántos entraron al programa y acá volvemos a repetir en tratamiento polillep, Viste Ese filtro que dijimos de poner al principio. Respetemos la leyenda y que sea en tratamiento poli.

20:35 GUSTAVO V.I.: Donde dice la entraron al programa que cambiarlo por tratamiento.

20:36 Karina C.: Ep Sí pone tratamiento polillette porque si no se nos va a confundir la palabra programa viste entonces del total que fueron al consultorio, que ahí está perfecto, que es lo que vos pusiste 379 en azul. Esos 125 tiene que decir en tratamiento, poly. Bien, y después qué más había abajo del tablero Ah laboratorio, perfecto que

21:02 GUSTAVO V.I.: el laboratorio está

21:05 Karina C.: son los que dijeron que sí. Cuántos tienen diabetes cuando eso

está perfecto

21:11 GUSTAVO V.I.: Después acá abajo, yo dejé como estaba revisalo vos.

21:12 Karina C.: y a vos lo dejaste Sí eso, yo te iba a preguntar. Vos que ahí dejaste como generales Cuántos registrados, Cuántas cargadas,

21:20 GUSTAVO V.I.: exacto Cuántas personas en programa, ves

21:25 Karina C.: okay, Y lo de riesgo que tomaste ahí.

21:31 GUSTAVO V.I.: Y riesgo está la fórmula hasta acá Cuántas personas distinta con antecedente activo de http previa.

21:37 Karina C.: O sea, toma Toma lo de arriba, toma chatea barrate alterada perfecto.

21:41 GUSTAVO V.I.: sí Igual si vos la iglesia arriba te da ves los diabéticos. Bueno, cuántas

21:44 Karina C.: después

21:48 GUSTAVO V.I.: personas distintas con antecedente activo de diabetes estos son los antecedentes?

21:54 Karina C.: Todos son antecedentes, no son bueno.

21:56 GUSTAVO V.I.: Son antecedentes este es antecedente, que es el mismo número que acá tres

22:00 Karina C.: porque

22:01 GUSTAVO V.I.: cuarenta y tres.

22:03 Karina C.: Ah bueno son todos antecedentes esos.

22:06 GUSTAVO V.I.: Para que revisamos. Este se ve Cuántas personas distintas tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, sí, esto antecedente antecedente alertas de tea, Cuántas personas distintas sin antecedente activo este no sin antecedente activo hta y conteas históricas mayores igual a 140 distólica 90.

22:30 Karina C.: O sea, Esos son los captados.

22:31 GUSTAVO V.I.: Estos son los captados que son estos mismos. Y alerta de laboratorio bueno, los que dieron los que dieron alguna alerta en el laboratorio ahí ahí, si querés decirme Vos cómo lo ubico.

22:42 Karina C.: Sí, escuchame, porque entonces yo sumaría sí. A ver, yo pondría juntas, Me parece bien hacer la diferenciación antecedente de hta y me parece bien hacer de alterada, o sea, acá me parece bueno poner las dos cosas porque porque ahora sí voy al laborar al todo lo que sucede por fuera de

laboratorio, o sea, como vos pusiste ahí en nenes, que pusiste ht antecedentes hta 343 y te ha no leo Bueno yo pondría como mes de alerta, el

23:16 GUSTAVO V.I.: alerta de tierra

23:21 Karina C.: mismo la misma leyenda que pusimos en el dashboard, T alta.

23:27 GUSTAVO V.I.: ok

23:28 Karina C.: Sí entonces esos dos los pondría como dos juntitos para diabetes volvería a poner como el título grande es diabetes, pero haría una separación pondría diabetes o glucemia alterada alterada. Y entonces ahí otra vez si vos los estás dividiendo uno es el que ya sabe que tiene diabetes y el otro que me aparezca Cuántos estoy detectando porque el programa también está detectando gente nueva Sí porque sé que te dijo No tengo diabetes, pero si es un laboratorio y le dio 250 de glucemia es un tipo que tampoco lo sabía, o sea, ahora estamos pasando otra patología nos estamos saliendo de la hipertensión, Si se quiere pero con la misma lógica el tipo te

24:08 GUSTAVO V.I.: No, no te entiendo.

24:12 Karina C.: dijo yo no tengo diabetes No ni idea y cuando se hace el laboratorio le da 250 cuando el límite sí está superando, Obviamente el límite, después hay que confirmar ese diagnóstico, pero a priori tenés un tipo que tiene una glucemia muy alta Sí entonces haría la misma diferenciación como los títulos grandes va a ser diabetes y después un como una un subtítulo o un Capi ahí chiquitito que diga con antecedente de diabetes y El otro Capi hay que diga Vamos a ponerle glucemia alterada en laboratorio, digo porque entonces todo lo que aparezca en laboratorios sabemos que es post, sí que el tipo no lo sabía Y es post, pero otra vez Gus hay que excluir al que te dijo que tiene antecedente porque si no solapa se entiende.

25:06 GUSTAVO V.I.: Sí sí, okay.

25:07 Karina C.: Perfecto, después para dislipemia es lo mismo la dislipemia se divide en colesterol alto y triglicéridos? Y pasa lo mismo está el tipo que tuvo que te dice si yo tengo colesterol alto Ya lo sé, tengo antecedentes, no me acuerdo la pregunta si está como ahí Perdón Que vuelvo.

25:26 GUSTAVO V.I.: Acá para que te digo cómo es cuenta persona distinta que antecedente activo esta cuenta los antecedentes nada más.

25:33 Karina C.: pero de dislipemia suma colesterol más triglicéridos

25:37 GUSTAVO V.I.: sí

25:38 Karina C.: lo suma

25:39 GUSTAVO V.I.: Creo que sí, no lo tengo.

25:41 Karina C.: A ver, vamos al no, porque ahí yo ahí también me hice una mezcla como pregunta en antecedentes, pues me parece que en antecedentes pregunta.

25:48 GUSTAVO V.I.: Para que me fijo como preguntan antecedentes.

25:50 Karina C.: sí

25:53 GUSTAVO V.I.: Vamos a la persona. A cualquiera y lo vemos. Vamos a este que tiene un montón. pregunta cardiovascular renal Crónica melitus para que te lo abran Lo que pasa que si te labrando se desarma

26:16 Karina C.: No, no, no, no, no lo veo, ahí lo veo.

26:19 GUSTAVO V.I.: Ah no dice colesterol y otra y glicéridos elevador.

26:20 Karina C.: listo Bueno ahí Entonces vamos a tener Está bien como antecedente vamos a poner a colesterol y o Está bien, está bien el término dislipemia Entonces vamos a poner dislipemia como título grande y uno lo mismo la misma lógica que venimos siguiendo con antecedente y que estén esos que dijeron acá que tienen antecedentes y el otro Capi hay que diga. El laboratorio alterado sí. Y el otro que nos queda.

26:57 GUSTAVO V.I.: Para sí, Ah de los antecedentes para que me fui.

26:58 Karina C.: Es creatinina. Pero ahí no se pregunta porque la creatinina es una medición y ahí le hay

27:08 GUSTAVO V.I.: No, no se pregunta ahí.

27:09 Karina C.: antecedente patología renal me parece

27:13 GUSTAVO V.I.: para que

27:16 Karina C.: a ver

27:17 GUSTAVO V.I.: cardiovascular Ah sí renal tiene enfermedad renal crónica

27:19 Karina C.: renal Bueno ahí hacemos otra vez el título va a ser enfermedad renal. Déjame ver algo usen, porque yo lo había puesto una manera, déjame un segundo nada más. Quiero que repitamos o si no, yo te voy a pasar esto después te lo paso en el limpio de los títulos por ahí. Sí, okay, Porque no importa igual La idea, es la misma Yo después te paso en

27:46 GUSTAVO V.I.: sí

27:47 Karina C.: limpio el título pero enfermedad renal tiene el antecedente el tipo que te dijo que sí y después El otro es un laboratorio alterado de creatinina

que no significa que el tipo vaya a tener enfermedad renal, pero es una alerta que te dice es un tipo que tuvo uno punto dos de creatinina por encima de los valores normales y este también es un tipo que está siendo captado político no tenía ni idea que su función y de su reunión funcionaba mal.

28:14 Karina C.: Pero bueno se entiende como esa lógica yo lo que te voy a pasar más en limpio

28:18 GUSTAVO V.I.: Sí el que encontramos con antecedentes porque te lo dijo y el que descubrí con

28:19 Karina C.: es el título. Sí, versus el que aparece en laboratorio exacto y ahí estamos y ya está Y eso

28:23 GUSTAVO V.I.: laboratorio.

28:29 Karina C.: listo Nada más no habría que ver nada más.

28:32 GUSTAVO V.I.: Okay.

28:33 Karina C.: Por ahora por lo menos que con esto estamos más que bien, eso no se lo de

28:35 GUSTAVO V.I.: O sea que esto bueno Esto lo cortes accionales hta sin tratamiento esto es

28:37 Karina C.: corto, es accionar, no sé qué es eso.

28:42 GUSTAVO V.I.: Cuántas personas distintas con antecedente activo y tratamiento hta de previa

28:42 Karina C.: Ah no, no sé no.

28:47 GUSTAVO V.I.: vacío

28:50 Karina C.: A ver, déjame ver un poquito porque eso como que no no terminó de no terminé de entenderlo.

28:56 GUSTAVO V.I.: Que vos lo encontraste el tipo que el tipo te dice que tiene que tiene, pero está sin tratamiento.

29:04 Karina C.: Ah bueno es interesante A ver para entonces te aparece el que dijo tener de hipertensión diabetes o lo que sea, pero no tiene tratamiento, o sea, eso sí, pega solo con antecedentes tiene sentido Bueno me gusta, sí. Pero no entendía lo de las Cortes accionables, le pondré otro título.

29:25 GUSTAVO V.I.: lo mismo pasa con nosotros con diabetes y

29:29 Karina C.: Sí pero esto antecedentes yo lo que pondría ahí es pacientes o personas con antecedentes. con antecedentes sin tratamiento

29:43 GUSTAVO V.I.: Ok bueno

29:45 Karina C.: Y dejemos esos los que te dijeron diabetes sí, sin tratamiento dislipemiasis,

29:51 GUSTAVO V.I.: Esto estos tres de acá arriba.

29:51 Karina C.: sin tratar bien sí, los otros.

29:57 GUSTAVO V.I.: En programas sin laboratorio cuenta personas activan programas que no tienen ningún laboratorio resultado activo?

30:03 Karina C.: Bueno ese puede ser eso lo que hace es contar el tipo que encima te dijo que no no tiene laboratorio, no, nada, o sea se rehúsa no podemos dejar

30:14 GUSTAVO V.I.: Acepta laboratorio sin resultado cuenta de persona activas con algún control domiciliario activo donde aceptan laboratorio y sin ningún resultado activo, o sea te dice que sí y pero no tiene activo ningún resultado, o sea, ningún

30:24 Karina C.: no

30:28 GUSTAVO V.I.: resultado dio mal.

30:28 Karina C.: Eso hay que ver si no es la demora en la carga de resultados por ahí ese por ahí lo sacaría ahora para no confundir.

30:36 GUSTAVO V.I.: Y sin control reciente cuenta en persona activa sin visita activa en los últimos 180 días eso. Pero bueno podemos sacarlo

30:43 Karina C.: Cómo sería ese?

30:45 GUSTAVO V.I.: Este cuenta personas activas sin visitas activas, o sea, están en el programa o están activas en realidad son personas que están, pero no hubo visita en 180 días para saber los que no se están quedando como basura si querés.

31:03 Karina C.: Pero es un tipo que te tuvo que haber rechazado el el consultorio directamente.

31:08 GUSTAVO V.I.: Está activa él la persona está sí te aceptó, pero no vino nunca, claro.

31:14 Karina C.: No fue al consultorio igual Eso sale de arriba porque Déjame ver bus, Porque si entonces arriba tenemos los que están en van al consultorio es la diferencia.

31:27 GUSTAVO V.I.: Sin Control reciente

31:28 Karina C.: arriba arriba

31:30 GUSTAVO V.I.: Sí, acá de este.

31:31 Karina C.: Claro, o sea tendría que darnos la diferencia de los 300 estos.

31:38 GUSTAVO V.I.: de estos

31:38 Karina C.: Este tres setenta y nueve O sea la diferencia de los que tuvieron ht, alterada tiene que estar ahí porque son los que tuvieron hta y no quisieron ir al consultorio. Ese me gustaría arriba. Me parece que es importante si bien es la

31:51 GUSTAVO V.I.: sí

31:57 Karina C.: diferencia. Subime un cachitín, porfa.

32:03 GUSTAVO V.I.: Voy Ahí vamos en este.

32:04 Karina C.: yo tengo Todos 586 son los que obtienen antecedentes o tienen la alterada menos tres setenta y nueve son 207 personas. Esas 207 igual te lo dice porque vos estás diciendo que el 65% fue el consultorio, o sea, te queda un 35 que no. Por ahí puede estar, no sé dónde está eso sí está abajo. O sea, para mí tendría que ser estos 207 se entiende.

32:37 GUSTAVO V.I.: Sí está bien, pero no es ese número entonces.

32:39 Karina C.: no

32:42 GUSTAVO V.I.: No es este número de personas sin actividad, igual tengo que ver en la búsqueda, qué búsqueda hace una base de datos?

32:47 Karina C.: A mí, claro, esa sería una búsqueda decir Bueno a ver si lo sacas por diferencia por supuesto, pero en algún lado poder decir Che son 207 que al fin no fueron al consultorio, o sea, tienen hta todo y los tipos dijeron, no? No, porque los motivos Ah eso sí falta te acordás los motivos de nota de no tratamiento.

33:15 GUSTAVO V.I.: bueno, y después está lo de calidad de datos que me sirve a mí más que

33:16 Karina C.: A ver dónde estaban Sí porque lo hablamos, pero no los vi acá. Si querés es ocultarlo o algo así está bien que queda abajo o ocultar o lo que sea, porque sabes lo que pasa que va a Mariana va a surgir la pregunta y todo el que lo mire va a preguntar entonces por ahí, si lo puedes ocultar

33:39 GUSTAVO V.I.: Sí sí lo oculto.

33:40 Karina C.: mejor.

33:43 GUSTAVO V.I.: Eso quedaron desde hacer un taller de prueba, viste y bueno quedó ahí.

33:47 Karina C.: OK Sí sí, sí, sí te sirve obvio, Sí sí pero por ahí oculto para que

no porque van a preguntar qué es que es Sabes qué Yo no vi eso de Por qué no no aceptó entrar a poli.

34:03 GUSTAVO V.I.: Para esto sería en la persona, no?

34:06 Karina C.: en la persona en consultorio

34:08 GUSTAVO V.I.: en persona en consultorio Para que lo vemos y ya está, tomemos una cualquiera. En la persona en consultorio en controles en el domiciliario. Accede al programa No acá, no lo pusimos porque el Por qué no no.

34:27 Karina C.: no no Pero en el consultorio sí.

34:39 GUSTAVO V.I.: En el de consultorio Sí para que agarro a alguien para no no generar ruido acá agarró alguien que tenga.

34:43 Karina C.: Sí, sí.

34:48 GUSTAVO V.I.: Dos consultorios justo habíamos visto alguien y ahora me olvidé de quién es.

34:52 Karina C.: Ahora no me acuerdo quién era no era el primero que aparecían ahí está

34:55 GUSTAVO V.I.: Es sí, Acá está.

34:57 Karina C.: perfecto, fíjate.

34:58 GUSTAVO V.I.: En consultorio acá sí lo pusimos.

35:03 Karina C.: Exacto Entonces si vos ponés que no entrega medicación exacto y ahí es eso,

35:06 GUSTAVO V.I.: Ahí te sale el seleccionar el motivo.

35:10 Karina C.: eso hay que ponerlo.

35:12 GUSTAVO V.I.: sí

35:13 Karina C.: eso motivo por el cual no entrega medicación y Y si tuvo un evento todavía no

35:25 GUSTAVO V.I.: Y acá está el evento, está y tenés que marcarlo.

35:29 Karina C.: Sí sí, esos dos hay que agregar son pocos porque por ejemplo, el otro día uno

35:30 GUSTAVO V.I.: O sea sí.

35:35 Karina C.: tuvo un infarto. O sea, por lo menos va a aparecer uno. Eso sabes de dónde se desprende.

35:43 GUSTAVO V.I.: Pero están para agregar, están parar, No no tengo que agregar, sino que lo tienen que usar digo.

35:50 Karina C.: Sí están usados poquitos porque están actualizando mira que se tenía entrega de medicación USA

35:56 GUSTAVO V.I.: Sí sí, ya está hasta Nada igual, salgo sin sin hacer nada.

35:57 Karina C.: okay, No eso Entonces los motivos Sin guardar de no entrega de medicación porque no quiere porque, o sea, el tipo En definitiva fue hasta el consultorio y dijo Bueno no hasta acá llegó y el de los eventos. que todos esos el denominador es

36:20 GUSTAVO V.I.: Que entraron al programa.

36:23 Karina C.: Sí en realidad, el del de no es el que fue al consultorio Ese es el

36:27 GUSTAVO V.I.: El de No no entró.

36:30 Karina C.: denominador. Y el de eventos es el de poly, ese es el denominador para eventos.

36:34 GUSTAVO V.I.: Sí, sí.

36:38 Karina C.: Sí, sí sí, sí, Exacto se quedó Yo igual. Ahora esto tiene que quedar grabado, pero esos son los denominadores para para

36:47 GUSTAVO V.I.: eso lo querés en un en el

36:50 Karina C.: Sí que se vea.

36:51 GUSTAVO V.I.: Okay Ah acá Bueno justo acá mejoré un mapa porque como ahora Estamos teniendo

36:54 Karina C.: Bueno, genial, y vos tenías algo?

37:04 GUSTAVO V.I.: mejor calidad de

37:06 Karina C.: De dato no.

37:07 GUSTAVO V.I.: De dato entonces pude mejorar en este no se ve lo tengo en uno de prueba, que ya Primero lo primero que hace Busca la dirección si la dirección está la ubica en el mapa.

37:18 Karina C.: Buenísima.

37:19 GUSTAVO V.I.: Y si no lo ubica por GPS y si no está no lo ubicas.

37:21 Karina C.: GPS genial igual de acá en adelante porque vamos a insistir mucho con esto el martes deberían todas pegar con GPS porque es lo que queremos Pero bueno buenísimo que tenga la opción esa sí.

37:35 GUSTAVO V.I.: Sí Y porque como obtener otro mapa más como para este.

37:39 Karina C.: Y ese que pusiste mapa de hta?

37:42 GUSTAVO V.I.: Sí está bien, pero ese es por GPS nada más y este es el que está mal ahora porque no nos marca mucho.

37:46 Karina C.: Ah!

37:48 GUSTAVO V.I.: Entonces por ahí en este o después Busco la vuelta de cuando estén normalizada más o menos las direcciones hacer como un repaso a toda la base de datos y tomar la el GPS de de una página en realidad desde una Api del gobierno que se llama georef que sirve para estas cosas. Sí sirve para normalizar de

38:10 Karina C.: No la conozco, mira.

38:14 GUSTAVO V.I.: localidad de direcciones Y eso que es parte lo que le puse yo ahora a cuando

38:16 Karina C.: Okay.

38:20 GUSTAVO V.I.: crean la vivienda.

38:23 Karina C.: Sí que toma el domicilio y no se pese.

38:25 GUSTAVO V.I.: No aparte de tomar el domicilio te pone el domicilio te te da Mira porque esto también ves que acá dice güiral del barrio y cuando yo voy acá me pone, ves avenida güiraldes. Camino José güiralde, camino Ricardo te lo sugiere porque

38:37 Karina C.: Ah sí Te lo sugiere.

38:44 GUSTAVO V.I.: esto es todo normalizado.

38:44 Karina C.: sí Bien.

38:47 GUSTAVO V.I.: Ahí lo cambié porque ese es Avenida viral y te pone la calidad del dato acá, te dice de baja confianza porque no ves que el GPS está a 50 mil metros. Es una es para nosotros como queda la de baja confianza.

39:00 Karina C.: Está buenísimo. claro

39:05 GUSTAVO V.I.: Pero esto es para el mapa, no, porque es de bajar sí, Y acá se acá les pone

39:08 Karina C.: Sí, sí, sí, sí se entiende.

39:10 GUSTAVO V.I.: Ahora vas a ver que cuando vos Tomás desde el teléfono se ponen todos en verde porque esto es porque están hechos de compu, por eso le puse así.

39:19 Karina C.: eso de baja media es lo que me decís porque no parece no parece para

39:22 GUSTAVO V.I.: Es la calidad es la calidad del dato y en otro y cuando no tiene nada, que no ya no sirve el dato para que había algunos acá, que le pusieron, no sé por qué le pusieron casa, no estos son los que está cargando

Aldana que son los del piloto.

39:39 Karina C.: Lo tiene el nombre.

39:40 GUSTAVO V.I.: Que no tenían casa, pero fíjate que le han puesto mucho, le han puesto casa, siete casa ocho no han puesto nada.

39:47 Karina C.: No, bueno, es otra cosa de reforzar esa. Quédate tranquilo que hubo nada.

39:50 GUSTAVO V.I.: Acá Mirá nada, pero pero bueno.

39:53 Karina C.: Sí, sí sí.

39:58 GUSTAVO V.I.: Nada, esto era Y si de paso si están ahí me gustaría hacer como un repaso de Cómo quedó ahora porque facilita que ellos puedan tomar el dato no me ponen todo minúscula No importa. Ya se queda todo bien viste.

40:11 Karina C.: Te toma todo en la letra normaliza la letra.

40:15 GUSTAVO V.I.: Normaliza la letra ellos ponen la dirección la ponen mal, igual le da la

40:17 Karina C.: dije Genial

40:20 GUSTAVO V.I.: sugerencia.

40:21 Karina C.: Las opciones no, no está eso lo lo tratamos O sea ya te digo de nueve nueve y media es el refuerzo de carga recargar cargar y de después nueve y media cuando vos llegues por ahí comentarles esto que te normalice el dato que es más fácil todas las mejoras.

40:40 GUSTAVO V.I.: porque yo sé que tomarlo en tablet y además muchos llevan sus teléfonos viste, está chiquito Yo entiendo que

40:45 Karina C.: sí Sí que no se ve bien, sí.

40:49 GUSTAVO V.I.: Que no se ve bien, bueno, estuve insistiendo en estas cosas yo en la parte de la experiencia, pero bueno Espero que ahora sí lo puedan cargar porque dicen que las tablets se le quedan sin batería y vienen con todo eso.

41:02 Karina C.: y bueno, igual te hable chido anteriores, pero no está bien cargada Bueno nada,

41:05 GUSTAVO V.I.: sí

41:05 Karina C.: son cosas son otras cosas son cosas que no no y va a ser fuente de la de la

41:08 GUSTAVO V.I.: Son excusas viste.

41:12 Karina C.: charla de antes que vos llegues, Porque esas, son cosas listo su

compromiso es salir con la tablet cargada que esté al 100% si vos sabes que va a estar cuatro horas en terreno o tres horas prever eso digo sí o sí marcar, digo son cosas que Pero por eso es por fuera de tu no te no queremos que vos te comas esa charla en realidad Porque va a ser una cuestión Clara

41:34 GUSTAVO V.I.: se va a poner viste Pero ya, porque aparte Ya conozco, viste empiezan y pero

41:39 Karina C.: Sí por eso, pero bueno, es ver qué pasa que dicen y sobre eso bueno, ver si realmente no funciona la tablet por ahí quedó alguna que haya quedado vieja Bueno si es eso veremos qué pasa pero

41:50 GUSTAVO V.I.: Les pediste que te lo lleve que te lleven las tablets?

41:52 Karina C.: Sí que vayan con celos o tablets según lo que usen para esta aplicación. Así que todos van a ir, sí van a estar todos además de de ellos tres que

42:01 GUSTAVO V.I.: Así ya.

42:04 Karina C.: están haciendo ahora porque en un futuro La idea es que los otros chicos que ahora no están en el proyecto lo hagan entonces ya que estamos que estén todos así todos Hablamos todos el mismo idioma y sabemos De qué trata.

42:20 GUSTAVO V.I.: Ok Ok bueno

42:21 Karina C.: Bien Ah bueno perfecto, Gus yo pongo pausa, no con pausa, ya estoy y eso me lo

42:28 GUSTAVO V.I.: Sí después te mando un mail.

42:30 Karina C.: sube directo, te pregunto porque así lo hice, pero tengo miedo como no veía botones de stop. Si eso lo vi en algunos. Yo sé poquitos Pero bueno en esos vi, pero no encontraba la transcripción en en uno que fue del otro día, pero para mí porque me estoy equivocando el lugar entonces pongo pausa y ya está.

[View original transcript at Tactiq.](#)